

RENATA PARADA BRANAS	
MEDICAMENTOS:	Smiltoide / Tibolona / sertralina / <u>Ritalina</u> LA
SINTOMAS/QUEIXAS	TDH / Sonolência / memória / Enjôma
BANHEIRO	OX
HORA QUE ACORDA	6hr
HORA QUE DORME	00:30
	IAH = 655/h
PRATICA EXERCICIO	Pilates 2x Musculação 1
HORARIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE: 7hr	ALMOÇO: 12:30 LANCHE: N JANTA: Canche
29/10/22	P = 9.0 IAH = 19.3/ev SpO2 - 85%
Quali// do sono 0.	
Desperta muitas vezes	
Boca seca + + + +	
08/11/22 pt relata sonolência, devido desper- tares, incomodo q o fixador (coloco- proteção. Oriento qto a regulariz/ do sono pois esta irregular. Ajusto a pressão.	
29/11/22 P = 11 cmH2O (média 9 cmH2O) IAH = 16.9 e/ev (IA = 11.4 e/ev) m. de uso: 5h49'	
Bem adaptada mas ainda q sonolência, porém é uma dormidore longa.	
Oriento uso de elev. da cabeceira esta q gases estomacal	
22/12 22	P = 9 cmH2O IAH = 9.9 e/ev m. de uso: 7hr Bem adapt. porém q sonolência - fu
27/03 23	P = 9.0 cmH2O - média 7.5 IAH = 9.7 e/ev m. de uso: 6h45' fu
28/11 23	P = 8.4 cmH2O IAH = 7.6 e/ev m. de uso: 7h36' Relata melhora do quadro fu
04/09/24	P = 6.8 cmH2O P95%: 8.8 cmH2O m. de uso: 7h38 min. toma zolpidem - IAH = 7.9 e/ev. piora sonolência selin fuca = 61mm. auto 5 a 11 cmH2O ↓ P: 5 a 9 cmH2O.

Dr. Mário Sérgio L
Otorrino

02/12/24 P=7.2 (↑ 5-10 cmH₂O)
IAH=6.2 1x ao banheiro
m. de uso: 6h40' João

23/01/25 P=7.6 cmH₂O ↑ P inicial = 6 cmH₂O
IAH=9.6 elh
m de uso: 8h23' Natasha

26/02/25 P=7.8 cmH₂O.
IAH=3.9 elh
m uso=7horas
fuga=

tonna zolpidem - piquinho
deputa à noite Silvia

IAH?

26/03/25 P=7.5 cmH₂O Pao: 8.4 cmH₂O
IAH=7.8 elh
m uso=7horas
fuga=

Auto 7.5 a 10.0 cmH₂O
P inicial 6 cmH₂O

Dorme tarde 01h chega do trabalho
Acorda 10h tarde.
↑ pressão máxima 8.5 cmH₂O

02/05/2025 P=8.9 cmH₂O
IAH=4.0 elh
m uso=7.5 horas
fuga=0.9 l/min

dorme tarde Auto 8.5 a 10 cmH₂O

02/07/2025 P=8.58 cmH₂O.
IAH=3.71 elh
m uso=6h38min
fuga=5 l/min

Auto 8.5 a 10 cmH₂O.
P inicial 5 cmH₂O.

foco fixador Dream wear

Silvia
Silvia

te: RENATA PARADA I
rio: Santa Casa Saúde
ula: 214229811930011

rio médico.

ente com indicação
m H₂O

ofisio
a Santa Elza 4
13921-1001

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologia

Paciente: **RENATA PARADA BRANAS** (53 anos)
Convênio: **Santa Casa Saude**
Matrícula: **214229811930011**

Relatorio medico.

*Paciente com indicação de uso de CPAP na pressão titulada de
9,0 cm H2O*

*Sonofisio
Rua Santa Elza 418
Tel 3921-1001*

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57.250

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

*Av. Mal. Floriano Peixoto, 347- 4. And Sala 402 Centro Fone: (12) 3922-5011
Cep 12210-030 São José dos Campos / SP*

Nome: RENATA PARADA BRANAS

Data de Nascimento: 25-10-1969

IMC: 32,41

Sexo: Feminino

Data do exame: 23-09-2022

Peso: 84 kg

Altura: 1,61 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 23-09-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 466,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 15,5 e 127,5 minutos. O tempo total de sono foi de 417,0, eficiência de 89,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 50,5%; estágio N3: 23,7%; sono REM: 24,1%. O índice de despertares foi de 15,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 19,3/hora, sendo elas 47 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 86 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 85%, permanecendo 1,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 93 bpm e NREM de 55 - 101 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM normal;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (17,3/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

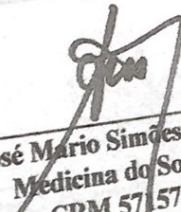
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: RENATA PARADA BRANAS
Data de Nascimento: 25-10-1969
IMC: 32,41
Sexo: Feminino
Data do exame: 10-08-2022

Peso: 84 kg
Altura: 1,61 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Nome: RENATA PARADA
Data de Nascimento: 25-10-1969
IMC: 32,41

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 10-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 486,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 32,5 e 114,5 minutos. O tempo total de sono foi de 395,0, eficiência de 81,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 66,6%; estágio N3: 10,5%; sono REM: 20,4%. O índice de despertares foi de 41,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 65,5/hora, sendo elas 68 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 168 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 31% (artefato de técnica), permanecendo 34,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 92 bpm e NREM de 35 - 96 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

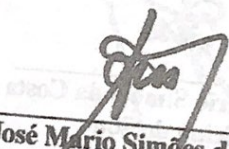
1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 65,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=31% artefato de técnica);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Obs.: Presença de artefato na oximetria de pulso.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: RENATA PARADA BRANAS
Data de Nascimento: 25-10-1969
IMC: 32,41
Sexo: Feminino
Data do exame: 23-09-2022

Peso: 84 kg
Altura: 1,61 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 23-09-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 466,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 15,5 e 127,5 minutos. O tempo total de sono foi de 417,0, eficiência de 89,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 50,5%; estágio N3: 23,7%; sono REM: 24,1%. O índice de despertares foi de 15,8/hora (normal < 10/h).

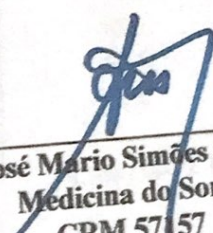
O índice de apneia/hipopneia total foi de 19,3/hora, sendo elas 47 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 86 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 85%, permanecendo 1,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 93 bpm e NREM de 55 - 101 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM normal;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (17,3/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.
Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: RENATA PARADA BRANAS
Data de Nascimento: 25-10-1969
IMC: 32,41
Sexo: Feminino
Data do exame: 10-08-2022

Peso: 84 kg
Altura: 1,61 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 10-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 486,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 32,5 e 114,5 minutos. O tempo total de sono foi de 395,0, eficiência de 81,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 66,6%; estágio N3: 10,5%; sono REM: 20,4%. O índice de despertares foi de 41,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 65,5/hora, sendo elas 68 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 168 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 31% (artefato de técnica), permanecendo 34,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 92 bpm e NREM de 35 - 96 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

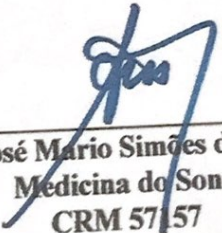
1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 65,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=31% artefato de técnica);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Obs.: Presença de artefato na oximetria de pulso.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157